

INFILTRACIONES GENERALIDADES

Julio Tito Camino Acha, Rubén López González, María de Mar Bances, Luis Alfredo Alonso Cuesta, Jesús Rodríguez Sarabia, Juan José González Fernández.

INFILTRACIÓN

Técnica o procedimiento que consiste en la administración local de fármacos en partes blandas o articulaciones, con el fin de conseguir efectos analgésicos, antiinflamatorios y mejorar su funcionalidad. Dado que las infiltraciones pueden tener efectos secundarios (dolor transitorio tras administrar el fármaco, hematoma local, infección, etc), sólo se debe infiltrar cuando hay un diagnóstico claro y preciso. Antes de infiltrar siempre informar al paciente y firmar consentimiento informado.

GENERALIDADES

- Repasar la anatomía de la zona a infiltrar.
- Asepsia y antisepsia rigurosa de la zona: Povidona yodada, alcohol 70º, etc.
- Material preparado y adecuado: guantes, gasas, campos, agujas (una para cargar la medicación y otra para infiltrar), jeringas estériles, fármaco (corticoide) y anestésico local.
- Evitar infiltrar en vía vascular (siempre aspirar antes de infiltrar). Reposo relativo 24-48h post-infiltración.
- Deporte después de más de 5 días de reposo.
- No infiltrar más de dos articulaciones en una misma sesión. No infiltrar una misma articulación más de 4 veces al año.
- No infiltrar más de 2 veces al año en la misma articulación si son ineficaces. Espaciar las infiltraciones entre 7 días y un mes.

Indicaciones	Contraindicaciones
• Respuesta no adecuada al tratamiento farmacológico oral o rehabilitador. • Mono u oligoartritis agudas o crónicas no infecciosas. • Patología articular inflamatoria o de tejidos blandos (tendinitis, fascitis).	• Reacción alérgica medicamentosa a anestésicos locales tipo amida. • Signos de infección periarticular o articular. • Trastornos graves de la coagulación o toma de anticoagulantes. • Diagnóstico no preciso. • Paciente con diabetes mal controlado. • Prótesis articular. • Desconocimiento de la técnica a usar. • Personal médico no entrenado.

COMPLICACIONES

- Infección de la zona de infiltración, con tasa de infección: 1 /10.000 infiltraciones.
- Hemartros.
- Hematomas.
- Atrofia cutánea o despigmentación de la piel en la zona infiltrada (revierten en meses).
- Lesión tendinosa (no recomendable infiltrar tendón Aquiles y rotuliano).
- Lesión del cartílago.
- Reacción alérgica a los fármacos usados en la infiltración. Aumento del dolor en la zona de la infiltración (transitorio).

FÁRMACOS

Anestésicos locales

Tienen como objetivo disminuir el dolor postinfiltración.

- Lidocaína 1%
- Mepivacaina (Scandibsa®).
- Bupivacaína B. Braun 2,5 mg/ml, 5mg/ml y 7mg/ml solución inyectable.
- Las cantidades de anestésico local varían en función de la zona a infiltrar.

Corticoides

FÁRMACO	DOSIS		
Nombre	Articulaciones Grandes	Articulaciones Medianas	Articulaciones Pequeñas
Trigon Depot® 40 mg/ml (triamcinolona)	20 - 40 mg (0,5 - 1 ml)	10 - 20 mg (0,25 - 0,5 ml)	2,5 - 5 mg (0,0625 - 0,125 ml)
Celestone Cronodose® 12 mg/2ml (betametasona)	6 - 12 mg (1 - 2 ml)	3 - 6 mg (0,5 - 1 ml)	1,5 - 3 mg (0,25 - 0,5 ml)

- Triamcinolona acetónido (Trigon depot® 40 mg/1ml): Ampollas de 1ml.
- Betametasona acetato y fosfato (celestone cronodose® 12 mg/2ml) : Ampollas de 2ml.

BIBLIOGRAFÍA

- http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2007/modulos/modulo1/trauma1.php
- Abreu MA. Técnicas de artrocentesis. SEMFYC ediciones. Guía de Actuación en Atención Primaria: 3ª edición. Barcelona. 2006: 1742-45.
- Barraquer Feu ME, Mas Garriga X. Guía de actuación en atención primaria: Infiltraciones en extremidades inferiores. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1753-6.
- Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios Ficha técnica: Trigon Depot, celestono cronodose.
- Técnicas de infiltración. Manual práctico. Edo Llobet M, Marzal Herce E, Viladot Pericé R. Barcelona 2001.